

Алгоритм проведения маммографического скрининга

Жакенова Ж.К., Хамзин А.Х., Ткачева А.М.

Казахский НИИ Онкологии и Радиологии

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

Актуальность

Во всем мире рак молочной железы (РМЖ) – наиболее распространенное злокачественное заболевание и ведущая причина смертности среди женщин (Семиглазов В.Ф. и соавт., 2007, Benson J.R. et al., 2009). В Республике Казахстан РМЖ стабильно занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости женщин, начиная с середины 90-х годов XX века (Сейтказина Г.Д., 2005), а с 2007г. вышел на второе место в общей структуре онкологических заболеваний населения Казахстана (Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д. и соавт., 2008).

Маммография остается ведущим методом распознавания рака молочной железы, она не только позволяет выявлять самые ранние формы рака молочной железы, но также является информативным средством оценки местной распространенности опухоли и микрокальцинатов и дает возможность одновременно с диагностикой определять тактику лечения. Наряду с маммографией получила широкое распространение в маммологии и ультразвуковая диагностика (Weismann C.F. et al., 2007, Taplin S. et al., 2008). Внедрение и выдвижение новых правил проведения маммографического скрининга в РК требует объединения маммографии, УЗИ и трепанбиопсии молочных желез в руках одного специалиста – врача-рентгенолога, занимающегося маммографией и диктует необходимость использования единого алгоритма обследования молочных желез.

Материал и методы

Разработанный алгоритм проведения маммографического скрининга включает в себя проведение профилактического маммографического обследования женщин в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет в районных, городских поликлиниках области/города/региона с двойной интерпретацией и архивацией скрининговых маммограмм в областных/городских/региональных онкологических диспансерах.

Алгоритм

Маммограммы, сделанные в процессе скрининга женщинам в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет, из районных и городских поликлиник области/города/региона вместе с заполненной формой и результатом первой читки маммограмм поступают в областные/городские/региональные онкологические диспансеры, где проводится повторная интерпретация скрининговых маммограмм врачами-рентгенологами диспансера (вторая читка). Это значит, что каждая скрининговая маммограмма, сделанная в районных и городских поликлиниках области/города/региона, должна быть повторно сынтипретирована врачами-рентгенологами областного/городского/регионального диспансера по международной классификации BI-RADS. Если случай вызывает подозрение на злокачественный процесс по данным маммографии (М3 – больше данных за доброкачественный процесс, М4 – больше данных за злокачественный процесс, М5 – злокачественный процесс без патоморфологической верификации) у одного

Дан алгоритм проведения маммографического скрининга в РК с использованием «двойной читки» маммограмм и объединением маммографии, УЗИ и трепанбиопсии молочных желез в руках одного специалиста.

«Қос оқу» әдісін қолдану және маммография, УДЗ және сүт бездерінің трепанбиопсиясын біріктіріп, бір маман қолынан өткізу арқылы ҚР маммографиялық скринингтің өткізілу алгоритмы ұсынылған.

The algorithm mammography screening in Kazakhstan with additional “double reading» of screening mammograms and combination of mammography, ultrasonic and trepan-biopsy of breast tumors by one specialist is given.

из рентгенологов, то такой случай выносится на совместное обсуждение с другими рентгенологами диспансера, специалистами по заболеваниям молочных желез, для определения необходимости дальнейшего обследования. Если случай вызывает подозрение на злокачественный процесс по данным маммографии (М3 – больше данных за доброкачественный процесс, М4 – больше данных за злокачественный процесс, М5 – злокачественный процесс без патоморфологической верификации) у обоих врачей, то такая пациентка приглашается в диспансер на дальнейшее обследование – маммограммы прицельные и с увеличением, физикальный осмотр молочных желез, ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез, пункция образования молочных желез под контролем УЗИ, стереотаксическая пункция микрокальцинатов. Все процедуры – интерпретация скрининговых маммограмм, по показаниям – прицельная маммография, физикальный осмотр молочных желез, УЗИ молочных желез, пункция под контролем УЗИ, стереотаксическая пункция проводятся только врачом-рентгенологом маммографического кабинета онкологического диспансера, имеющим сертификат тематического усовершенствования по лучевой диагностике молочных желез. Результаты маммографии после двойной интерпретации заносятся в бланк и вклеиваются в амбулаторную карту пациентки. Врачами-рентгенологами диспансера оценивается качество скрининговых маммограмм, сделанных в районных и городских поликлиниках и вносятся коррективы по улучшению качества маммограмм в работу маммографических кабинетов поликлиник области/города/региона путем выезда специалистов диспансера на места, проведением обучающих семинаров с врачами и рентгенолаборантами уровня первичного медико-санитарной помощи (ПМСП). Маммограммы архивируются в рентгенархиве диспансера и сохраняются на протяжении жизни женщины. План лечения женщин, у которых выявлен рак молочной железы при маммографическом скрининге, обсуждается на заседаниях мультидисциплинарной группы диспансера по диагностике и лечению рака молочной железы, которые организованы для повышения качества диагностики и лечения пациенток с заболеваниями молочной железы и для мониторинга маммографического скрининга в области/

городе/регионе.

Эффективность

Разработанный алгоритм проведения маммографического скрининга с повторной интерпретацией скрининговых маммограмм на уровне маммографического кабинета онкологического диспансера врачами-рентгенологами, которые по показаниям проводят прицельную маммографию, УЗИ молочных желез и инвазивные процедуры, позволит улучшить качество маммограмм, повысить выявляемость рака молочной железы в ранних стадиях на 20%, повысить качество лечения с использованием мультидисциплинарного подхода, сократить время с момента проведения скрининговой маммографии до оказания специализированной помощи. Мультидисциплинарный подход к лечению рака молочной железы, выявленного в процессе скрининга, позволит увеличить безрецидивный период течения данного заболевания.

Вывод

Правильно организованный и проведенный алгоритм маммографического скрининга в областных и региональных

онкологических диспансерах с использованием «двойной читки» маммограмм и объединением маммографии, УЗИ и трепанбиопсии молочных желез в руках одного специалиста – врача-рентгенолога онкологического диспансера позволит повысить эффективность скрининга и увеличить выявление рака молочных желез в ранних стадиях на 10-20% и более.

Литература

1. Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В., Нургазиев К.Ш. Обоснование стандартов лечения рака молочной железы. – Алматы, 2007. – 364 с.
2. Benson J.R., Jatoi I., Keisch M. et al. Early breast cancer // *Lancet*. – 2009. – Vol. 373. – P. 1463–79.
3. Сейтказина Г.Д. Особенности распространенности рака молочной железы в Западно-Казахстанской области // Сборник научных трудов Республиканского научно-практического семинара «Актуальные проблемы онкопатологии репродуктивной системы женщин». – Астана, 2005. – С. 42 – 43.
4. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан в 2007 году: статистические материалы. – Алматы, 2008. – 52 с.